Habilidades Cirúrgicas

Monitoria de TOCE

Revisão Flash · Sessão 03

Apendicite e Colecistite

O essencial para a prova em uma página

Técnica Operatória e Cirurgia Experimental
UniBH Vespasiano

8º período · 2026.2

Elaborado por João Batista Fernandes Júnior · *Monitor de TOCE*

Revisado pela Profa. Fernanda Parreiras

Não é referência bibliográfica

Não serve como material para recurso: a fonte original deve ser consultada.

Apendicite e colecistite

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Apendicite: escore + imagem no risco intermediário, laparoscopia, antibiótico curto e isolado só em selecionados. Colecistite: Tóquio, ultrassom, colecistectomia precoce; drenagem só para quem não pode operar; icterícia é via biliar.

1. **Dor que migra** para a fossa ilíaca direita, anorexia depois da dor.
2. **Gestante:** ultrassom e ressonância; criança: ultrassom.
3. **Antibiótico isolado:** não complicada, sem fecalito, decisão compartilhada.
4. **Complicada:** antibiótico de 2–3 dias após controlar a fonte.
5. Cólica biliar passa em até 6 h; colecistite persiste. Sem Murphy ou febre não exclui.
6. **Tóquio II:** leucócitos acima de 18 mil, massa, mais de 72 h, inflamação local marcada.
7. **Colecistectomia precoce** até 7 dias da internação e 10 do início.
8. **Charcot:** febre, icterícia, dor = colangite; CPRE.

Tóquio · diagnóstico

Grupo	Exemplo
A local	Murphy
B sistêmico	Febre, leucocitose
C imagem	Ultrassom

Pegadinha

Icterícia importante não é da colecistite simples. Abscesso tratado no adulto mais velho: colonoscopia e considerar apendicectomia de intervalo.

Checklist antes da prova

- ☐ Sei a história típica da apendicite
- ☐ Escolho a imagem certa por paciente
- ☐ Sei tratar plastrão e abscesso
- ☐ Diferencio cólica biliar de colecistite
- ☐ Sei Tóquio diagnóstico e gravidade
- ☐ Sei o risco de coledocolitíase
- ☐ Sei a visão crítica de segurança